Bronquiolite Viral Aguda
Guia de estudo – Microbiologia e Parasitologia / Biossegurança

Graziele e Gabriel · Seminário Interdisciplinar – Turma 61 · 12/11/2026

1. Sua parte na apresentação

- Slides 2 a 5: o que é a bronquiolite, agente causador, transmissão e medidas profiláticas.
- Tempo-alvo: cerca de 4 minutos para a dupla (2 minutos cada).
- Divisão sugerida: Graziele – slides 2 e 3; Gabriel – slides 4 e 5.
- Vocês abrem o conteúdo técnico do seminário: o tom de vocês dá o ritmo do resto da apresentação.

2. Contexto: por que esta parte importa

A orientação do seminário pede, em Microbiologia e Parasitologia / Biossegurança: conceito, transmissão da doença e medidas profiláticas. É a base de tudo: as outras partes (anatomia, sinais, tratamento e dados) só fazem sentido depois que a banca entende qual é o agente e como ele chega ao bebê.

Para o técnico de enfermagem, esta parte tem impacto direto na prática: o VSR (Vírus Sincicial Respiratório) passa de um bebê para outro principalmente pelas mãos e por objetos. Ou seja, a própria equipe de saúde pode transmitir o vírus dentro do hospital se não fizer a higiene das mãos e usar os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) corretos. Por isso a biossegurança é parte da disciplina.

A grande novidade do tema é que, desde 2025/2026, o SUS (Sistema Único de Saúde) passou a oferecer duas formas específicas de prevenção: a vacina VSR para gestantes e o nirsevimabe para bebês de risco. Vocês apresentam isso de forma geral; a Bianca depois mostra os números na nossa região.

3. Sugestão de falas

As falas são um roteiro: não precisam ser decoradas palavra por palavra. Entenda a ideia e fale com as próprias palavras, olhando para a banca.

Graziele – Slide 2: O que é a bronquiolite? · *≈ 1 minuto*

"Antes de começar, uma pergunta: alguém aqui já teve um filho, sobrinho ou irmão internado com bronquiolite? (pausa) Pois é, é muito comum."

"A bronquiolite é uma infecção viral aguda que inflama os bronquíolos, que são as menores vias aéreas do pulmão. Ela atinge principalmente crianças menores de 2 anos, e os casos mais graves acontecem nos bebês com menos de 6 meses e nos prematuros."

"Não confundam com bronquite: a bronquite atinge os brônquios, os galhos grossos da árvore respiratória. A bronquiolite atinge os galhos finos, e por isso obstrui com tanta facilidade."

Graziele – Slide 3: Agente causador · *≈ 1 minuto*

"O principal causador é o VSR, o Vírus Sincicial Respiratório. Segundo a SBP, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ele responde por até 75% das bronquiolites."

"Outros vírus também podem causar: rinovírus, metapneumovírus, adenovírus, parainfluenza e influenza."

"A doença é sazonal: no Sudeste o VSR circula principalmente de março a julho, e em Minas a Secretaria de Estado de Saúde apontou o pico recente entre fevereiro e abril."

Gabriel – Slide 4: Transmissão · *≈ 1 minuto*

"O VSR se transmite de três formas: gotículas da tosse e do espirro, contato direto com secreções e superfícies contaminadas."

"Nas mãos, o vírus sobrevive menos de 1 hora, mas em superfícies duras, como um estetoscópio, pode durar até cerca de 24 horas. Por isso a higiene das mãos e dos materiais é tão importante para nós, da enfermagem."

"O período de incubação é de 4 a 5 dias."

Gabriel – Slide 5: Medidas profiláticas · *≈ 1 minuto*

"No dia a dia, a prevenção é simples: lavar as mãos com água e sabão ou álcool 70%, manter o aleitamento materno e evitar fumaça de cigarro e aglomerações com o bebê."

"E aqui está a novidade: o SUS passou a oferecer duas proteções específicas. A vacina contra o VSR para gestantes a partir da 28ª semana, que passa anticorpos para o bebê pela placenta, e o nirsevimabe, um anticorpo pronto aplicado em prematuros e crianças de até 2 anos com comorbidades."

"No hospital, o paciente fica em precaução de contato e gotículas. Agora a Fernanda e a Dayane vão mostrar o que esse vírus faz dentro do pulmão."

4. Conteúdo para estudar

Conceito

A BVA (Bronquiolite Viral Aguda) é uma inflamação aguda dos bronquíolos causada por vírus. Os bronquíolos são ramificações das vias aéreas com menos de 2 mm de diâmetro, que levam o ar até os alvéolos.

- Faixa etária: menores de 2 anos.
- Grupos de maior risco (SBP): menores de 6 meses, prematuros, crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade e cardiopatas.

Agentes etiológicos

O VSR responde por até 75% das bronquiolites e 40% das pneumonias em menores de 2 anos durante a sazonalidade (SBP, 2017). O nome "sincicial" vem do efeito do vírus nas células em cultura: ele faz as células vizinhas se fundirem, formando sincícios (massas com vários núcleos).

- Outros agentes: metapneumovírus humano, rinovírus, bocavírus, adenovírus, coronavírus, influenza e parainfluenza.
- A coinfecção (mais de um vírus ao mesmo tempo) pode acontecer.

Transmissão e biossegurança

- Vias: contato direto com secreções, superfícies e objetos contaminados (fômites) e gotículas de tosse e espirro.
- Porta de entrada: mucosas dos olhos, boca e nariz.
- Sobrevida do vírus: menos de 1 hora nas mãos; até cerca de 24 horas em superfícies duras e não porosas (SBP, 2017).
- Incubação: 4 a 5 dias. Eliminação do vírus: 2 a 8 dias, podendo chegar a 3 a 4 semanas em recém-nascidos e imunocomprometidos.
- No hospital: precaução de contato (avental e luvas) e de gotículas (máscara cirúrgica), além da higiene das mãos nos 5 momentos.

Prevenção pelo SUS (novidade 2025/2026)

Quem decidiu: a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) recomendou em 2025 a entrada das duas tecnologias no SUS, depois de a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovar o registro.

- Vacina VSR para gestantes: dose única a partir da 28ª semana. A mãe produz anticorpos que passam pela placenta e protegem o bebê nos primeiros meses de vida (imunização ativa da mãe). Faz parte do calendário do PNI (Programa Nacional de Imunizações) desde o 2º semestre de 2025.
- Nirsevimabe: anticorpo monoclonal (anticorpo "pronto"), dose única, aplicado no bebê (imunização passiva). Indicado para prematuros até 36 semanas e 6 dias e crianças menores de 24 meses com cardiopatia congênita com repercussão, doença pulmonar crônica da prematuridade, imunocomprometimento grave, síndrome de Down, fibrose cística, anomalias das vias aéreas, doenças pulmonares ou neuromusculares graves.
- Onde é aplicado: maternidades (bebê prematuro, antes da alta) e CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais), para as crianças de risco que já foram para casa.

5. O que revisar antes do seminário

- ☐ Explicar a diferença entre bronquite e bronquiolite sem olhar o slide.
- ☐ Saber o significado de VSR, SBP e de "sincicial".
- ☐ Decorar: até 75%, menos de 1 hora nas mãos, até 24 horas em superfícies, incubação de 4 a 5 dias.
- ☐ Diferença entre vacina (imunização ativa) e nirsevimabe (imunização passiva).

☐ Quem tem direito ao nirsevimabe e o que é o CRIE.

☐ Diferença entre precaução de contato e de gotículas, e quais EPIs cada uma exige.

6. Perguntas que a banca pode fazer

P: Existe antiviral ou antibiótico para bronquiolite?

R: Não. A doença é viral, então antibiótico não age sobre o vírus, e não existe antiviral de uso rotineiro: o tratamento é de suporte.

P: Por que o nome "vírus sincicial"?

R: Porque em cultura de células o vírus faz as células vizinhas se fundirem, formando massas com vários núcleos chamadas sincícios.

P: Qual a diferença entre a vacina da gestante e o nirsevimabe?

R: A vacina faz a mãe produzir anticorpos, que passam para o bebê pela placenta. O nirsevimabe é o próprio anticorpo, aplicado direto no bebê.

P: O que é a SBP e por que vocês usam ela como fonte?

R: É a Sociedade Brasileira de Pediatria, a entidade científica dos pediatras do Brasil. Ela publica diretrizes baseadas em estudos, que orientam como diagnosticar, tratar e prevenir. É a referência oficial da pediatria no país.

P: A criança pode pegar bronquiolite mais de uma vez?

R: Sim. A infecção pelo VSR não gera imunidade duradoura, e outros vírus também causam bronquiolite. As reinfecções costumam ser mais leves.

P: Quais EPIs usar com um bebê internado com VSR?

R: Precaução de contato e gotículas: avental, luvas e máscara cirúrgica, além da higiene das mãos antes e depois do contato.

7. Pegadinhas e erros a evitar

- Não dizer que o VSR causa "todos" os casos: são até 75%.
- Não dizer que o vírus sobrevive "horas nas mãos": são menos de 1 hora; nas superfícies é que dura até cerca de 24 horas.
- Não chamar o nirsevimabe de vacina: é um anticorpo monoclonal.
- Não confundir incubação (4 a 5 dias) com duração da doença.
- Ao falar uma sigla pela primeira vez, dizer o nome completo.

8. Glossário de siglas

Siglas que aparecem na apresentação e nos documentos. As mais importantes para a sua parte estão em destaque na seção 4; aqui está a lista completa para toda a equipe.

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
VSR	Vírus Sincicial Respiratório	Principal vírus causador da bronquiolite (até 75% dos casos).
BVA	Bronquiolite Viral Aguda	Nome completo da doença.
SBP	Sociedade Brasileira de	Entidade científica que reúne os

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
	Pediatria	pediatras do Brasil. Publica diretrizes, que são guias feitos a partir da análise de estudos científicos, para orientar médicos e equipes no diagnóstico e no tratamento. É a principal referência do trabalho: tudo o que dizemos sobre diagnóstico, tratamento, “indicado” e “não indicado” vem da diretriz da SBP de 2017.
AAP	American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria)	Equivalente americana da SBP. A diretriz de bronquiolite da AAP (2014) é usada no mundo todo e foi base para a diretriz brasileira.
SUS	Sistema Único de Saúde	Sistema público de saúde do Brasil.
SES-MG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Gestão da saúde no estado. Compra e distribui vacinas e imunobiológicos para as regionais, acompanha os casos de SRAG e publica os dados de VSR do estado.
SRS	Superintendência Regional de Saúde (de Montes Claros)	“Braço” da SES-MG no Norte de Minas. Coordena 54 municípios: recebe as vacinas do estado e repassa para as cidades e maternidades.
SMS	Secretaria Municipal de Saúde (de Montes Claros)	Gestão da saúde na cidade: postos, hospitais conveniados, vigilância. É a autora do Relatório Anual de Gestão.
RAG	Relatório Anual de Gestão	Prestação de contas anual da SMS: mostra dados de saúde da cidade e se as metas foram cumpridas. Precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
CMS	Conselho Municipal de Saúde	Grupo formado por usuários, trabalhadores, prestadores e governo que fiscaliza a saúde do município. Aprovou o RAG 2025 em 25/02/2026.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS	Órgão do Ministério da Saúde que guarda os bancos de dados oficiais do SUS (internações, óbitos, nascimentos).
TabNet	Ferramenta de tabulação do DATASUS	Site onde qualquer pessoa monta tabelas com os dados do SUS, escolhendo ano, local, idade e doença.
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	Banco que registra todas as internações pagas pelo SUS. De onde vêm os números de internação da apresentação.
AIH	Autorização de Internação	Documento que o hospital preenche para

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
	Hospitalar	o SUS pagar a internação. Cada AIH conta como uma internação no SIH.
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão	Código padronizado de cada doença. J20 = bronquite aguda; J21 = bronquiolite aguda.
SRAG	Síndrome Respiratória Aguda Grave	Quadro respiratório grave que leva à internação (febre, tosse, falta de ar, saturação baixa). Toda SRAG internada deve ser notificada, no SUS e na rede particular.
SIVEP-Gripe	Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe	Sistema onde os hospitais (públicos e particulares) notificam os casos de SRAG e o vírus encontrado no exame.
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz	Instituição de pesquisa do Ministério da Saúde.
InfoGripe	Boletim da Fiocruz	Analisa os dados do SIVEP-Gripe e mostra se os casos de SRAG estão subindo ou caindo em cada estado.
Unidade Sentinela	Serviço de vigilância de síndrome gripal	Unidade que coleta amostras de pacientes com síndrome gripal e envia para análise, para saber quais vírus estão circulando (VSR, influenza, COVID-19).
PNI	Programa Nacional de Imunizações	Programa do Ministério da Saúde que define o calendário de vacinas do SUS.
SI-PNI	Sistema de Informação do PNI	Sistema onde são registradas as doses aplicadas. É ali que se vê a cobertura vacinal (porcentagem do público vacinado).
CRIE	Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais	Serviço do SUS que aplica vacinas e imunobiológicos especiais, que não ficam nos postos comuns, para grupos específicos (prematuros, cardiopatas, imunossuprimidos). Na regional de Montes Claros, recebeu 503 das 766 doses de nirsevimabe, para atender crianças de risco que já saíram da maternidade.
Conitec	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS	Comissão que avalia se um remédio ou vacina deve entrar no SUS. Recomendou o nirsevimabe e a vacina VSR para gestantes em 2025.
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Órgão que autoriza o registro de remédios e vacinas no Brasil.

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
Nirsevimabe	Anticorpo monoclonal contra o VSR	Anticorpo “pronto”, aplicado em dose única no bebê de risco (imunização passiva). Não é vacina.
UTI	Unidade de Terapia Intensiva	Setor para pacientes graves.
PS	Pronto-Socorro	Atendimento de urgência.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Luvas, avental, máscara, óculos.
SSVV	Sinais vitais	Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e pressão arterial.
T	Temperatura (axilar)	—
FC / bpm	Frequência cardíaca / batimentos por minuto	—
FR / irpm	Frequência respiratória / incursões respiratórias por minuto	—
SpO_2	Saturação periférica de oxigênio	Medida pelo oxímetro de pulso. Abaixo de 92% persistente é sinal de alarme.
PA	Pressão arterial	—
O_2 / CO_2	Oxigênio / gás carbônico	—
SF 0,9%	Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%)	Usado na lavagem nasal.
SSH 3%	Solução salina hipertônica a 3%	Soro mais concentrado; pode ser nebulizado no hospital, por decisão médica.
COREN-MG	Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais	Órgão que registra e fiscaliza os profissionais de enfermagem. O número do COREN vai na assinatura da anotação.
IA	Inteligência artificial	—

9. Fontes desta parte

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. **Diretrizes para o manejo da infecção causada pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – 2017**. Rio de Janeiro: SBP, 2017. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20277e-Diretrizes_VSR.pdf. Acesso em: 4 nov. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Contra a bronquiolite: regional de Montes Claros alinha com maternidades uso de imunobiológico em bebês e crianças**. Belo Horizonte: SES-MG, 10 fev. 2026. Disponível em:

https://www.saude.mg.gov.br/noticias/contra-a-bronquiolite-regional-de-montes-claros-alinha-com-maternidades-uso-de-imunobiologico-em-bebes-e-criancas/. Acesso em: 4 nov. 2026.

AGÊNCIA BRASIL. **Vírus sincicial respiratório mata 13 crianças menores de 2 anos em MG**. Brasília: EBC, 12 jan. 2026. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-01/virus-sincicial-respiratorio-mata-13-criancas-menores-de-2-anos-em-MG. Acesso em: 4 nov. 2026.

10. Dicas gerais da equipe

- Divisão da equipe: Graziele e Gabriel (Microbiologia, slides 2 a 5); Fernanda e Dayane (Anatomia, slides 6 a 8); Fabricia (sinais e sintomas e sinais de alarme, slides 9 e 10); Letícia (diagnóstico e tratamento, slides 11 e 12); Celma (cuidados e anotação de enfermagem, slides 13 a 15); Bianca (dados e vacinação, slides 16 a 18). Abertura (slide 1) e conclusão (slide 19): a definir.
- Tempo total: 15 a 20 minutos. Cronometrem pelo menos um ensaio completo com todos (reunião de segunda-feira).
- A orientação exige que todos saibam todas as partes: se alguém faltar, a equipe assume. Leiam também o resumo das outras disciplinas e o glossário de siglas.
- Não leiam o slide. O slide mostra o dado; a fala explica o porquê.
- Se não souber uma resposta, não invente: diga que a equipe pode complementar e passe para quem domina aquela parte.
- Sempre que falar uma sigla pela primeira vez, diga o nome completo (ex.: “a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria”).
- Slides devem chegar à líder de turma até domingo (08/11); prazo final com a professora: 10/11.